

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-03-27T12:25:26

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07

Generated at: 2026-03-27T12:25:23

病理辅助角色声明

作为资深病理辅助助手，我的核心职责是基于提供的病理文本、图像信息及预测类别，为Query Case（TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07）提供精确的临床指标提取与辅助诊断意见。我将综合分析五份参考诊断报告、Query Case的二十张高注意力patch图像以及其预测类别（TCGA-PRAD），确保最终结论准确且逻辑一致。我不会签发最终诊断，仅提供基于现有证据的辅助建议，且严格遵循AJCC癌症分期手册的逻辑。所有推理过程将详细记录，确保透明度与可追溯性，同时避免任何可能的逻辑冲突或信息遗漏。本声明明确限定于Query Case，不涉及其他检索病例的直接诊断。

推理过程与证据归纳

推理过程与证据归纳：

首先，从五份参考诊断报告中提取关键信息。第一份报告（TCGA-HC-7079）描述了肿瘤大小为1.00厘米，病理分期为pT3a N0 Mx，淋巴结状态为0/4阳性，提示存在局部侵袭但无淋巴结转移。第二份报告（TCGA-CH-5754）指出双侧前列腺低分化腺癌，累及整个腺体，可见神经侵犯，且有淋巴结转移（1/多个），这表明更广泛的病变和更高的恶性程度。第三份报告（TCGA-G9-6494）显示高级别（Grade 4）肿瘤，大小为1.20厘米，病理分期为pT4 N0 Mx，淋巴结状态为0/2阳性，强调了肿瘤的侵袭性和局部扩展。第四份报告（TCGA-HC-8259）描述了仅在左叶发现恶性病变，占前列腺体积不到5%，Gleason评分为6，病理分期为pT2a Nx，提示早期局限性病变。第五份报告（TCGA-EJ-8468）则记录了Gleason评分为8的高级别肿瘤，最大直径1.8厘米，病理分期为pT3a N0 Mx，无淋巴结转移，但存在血管淋巴管侵犯。

结合Query Case的20张高注意力patch图像分析，这些图像主要展示了腺体结构的破坏、细胞异型性显著、核分裂象增多以及间质浸润等特征，符合前列腺腺癌的典型形态学表现。图像中未见明显淋巴结转移迹象，支持N0的可能性。同时，部分区域显示出较为明显的组织侵袭，与pT3a或更高分期相吻合。

Query预测类别为TCGA-PRAD，即前列腺腺癌，这一分类与上述形态学观察和参考报告中的病理类型高度一致。综合考虑，Query Case的肿瘤可能具有一定的侵袭性，但未见明确的淋巴结转移证据。

最终，基于以上证据链，Query Case:

TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07

的辅助诊断意见倾向于前列腺腺癌，病理分期可能为pT3a N0 Mx，具体分级需进一步结合Gleason评

分确定。值得注意的是，虽然存在局部侵袭，但目前证据支持无淋巴结转移，后续仍需密切随访以评估潜在的远处转移风险。

关键指标提取

关键指标提取

在综合分析5份参考诊断报告、Query的20张高注意力patch以及Query预测类别（TCGA-PRAD）后，我们可以尝试提取Query Case:

TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07的关键临床指标。

首先，从参考诊断报告中，我们注意到多个病例涉及前列腺癌（TCGA-PRAD），这与Query预测类别一致。其中，TCGA-HC-7079和TCGA-EJ-8468两个病例提供了较为详细的肿瘤大小和分期信息。TCGA-HC-7079报告显示肿瘤大小为1.00厘米，病理分期为pT3a N0 Mx，淋巴结状态为0/4阳性。而TCGA-EJ-8468报告则显示最大肿瘤直径为1.8厘米，病理分期同样为pT3a N0 Mx，淋巴结状态为0/13阳性。这些数据提示我们，Query Case可能具有类似的肿瘤特征。

其次，结合Query的20张高注意力patch图像证据，虽然具体的数值无法直接从图像中读取，但通过观察可以推测肿瘤组织存在一定的异型性和侵袭性，支持上述参考报告中的病理分级和分期推测。图像中未见明显淋巴结转移迹象，进一步佐证了N0的可能性。

最后，关于免疫组化指标如ER/PR/HER2和Ki-67，参考报告中并未提及具体数值，且由于Query Case为前列腺癌，通常不涉及乳腺癌相关的ER/PR/HER2检测。因此，这些指标在本案例中可视为“未提及”。

综上所述，基于现有证据，我们可以初步推测Query Case的肿瘤大小可能接近1.00厘米至1.8厘米之间，病理分期可能为pT3a，淋巴结状态为N0（即0/总数阳性），M分期为MX（因缺乏远处转移证据）。然而，由于缺乏直接的文本描述和明确的图像定量分析，这些推测仍需谨慎对待，并建议进一步补充相关检查以确认最终诊断。本结论针对 Query Case:

TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07。

初步病理辅助结论

初步病理辅助结论

基于提供的5份参考诊断报告、Query Case的20张高注意力patch图像以及预测类别TCGA-PRAD，综合分析后得出以下初步病理辅助结论。本结论针对 Query Case:

TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07。

首先，从参考诊断报告中提取的关键信息显示，前列腺癌（TCGA-PRAD）病例通常涉及腺癌类型，具有不同的Gleason评分和分期。例如，TCGA-HC-7079病例描述了肿瘤大小为1.00厘米，病理分期为pT3a N0 Mx，淋巴结状态为0/4阳性；而TCGA-CH-5754病例则展示了双侧低分化腺癌，累及整个腺体，可见神经侵犯，且有淋巴结转移（1枚阳性）。这些报告提供了关于肿瘤特征、分期和淋巴结状态的重要背景信息。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，观察到的组织学特征与前列腺癌的典型表现相符，包括腺体结构的异常和细胞异型性。虽然具体的量化指标如肿瘤大小和Gleason评分无法直接从图像中精确测量，但图像证据支持了前列腺癌的诊断方向。

根据Query Case预测类别为TCGA-PRAD的信息，进一步佐证了上述病理特征和诊断倾向。考虑到参考报告中的多种分期和分级情况，推测Query Case可能具有类似的肿瘤特征，但具体细节需要结合更多临床数据进行确认。

综合以上分析，初步推断Query Case可能表现为前列腺腺癌，具有一定的侵袭性和潜在的淋巴结转移风险。然而，由于缺乏具体的肿瘤大小、Gleason评分和淋巴结状态等关键指标，目前只能做出较为宽泛的推测。建议进一步补充详细的病理报告，包括明确的肿瘤大小、Gleason评分和淋巴结检查结果，以完善最终诊断。

在没有更详细信息的情况下，本结论仅基于现有证据进行合理推测，并强调后续需要更多的临床和病理数据来验证和细化诊断。本结论针对 Query Case: TCGA-CH-5748-01Z-00-DX1.032202f2-70c0-4115-99ff-1cecf4042e07，不将任何检索病例作为主诊断对象。